Sujet n°1 : SDD 58 Splénomégalie

Spécialité : Médecine interne

Date : 11/10/2023

Auteur : Ambroise LE POGAM (DES de médecine interne - ECN 2018)
Relecteur(s) : Sébastien VILLARD (DES de médecine interne - ECN 2023)

Domaine d'apprentissage principal	Examen clinique
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie diagnostique
Item(s) en lien avec la station	275 - Splénomégalie
Situation(s) de départ en lien avec la station	16 - Adénopathie 21 – Asthénie 58 - Splénomégalie
Matériel nécessaire à la station	Table d'examen
Contexte de la station	Consultation aux urgences

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :

Vous êtes un médecin de garde aux urgences.
Un patient de 25 ans, M. Adam Baudelaire, vous est adressé par son médecin généraliste pour une perte de poids récente de 5 kg en 2 semaines et une asthénie. Il a retrouvé à l'examen clinique une splénomégalie ainsi que des adénopathies périphériques.

Il est étudiant en droit, n'a pas d'antécédent personnel ni familial de cancer, ne prend aucun médicament. Il n'a jamais eu de problème de santé, ses vaccinations sont à jour et il n'a pas voyagé récemment.

En réinterrogeant le patient, vous apprenez qu'il présente depuis plusieurs semaines des fièvres récurrentes et des sueurs nocturnes. Il n'a pas d'autres symptômes, notamment pas de céphalée, pas de diarrhée, pas de brûlure urinaire, pas de toux, pas d'angine.

Constantes : TA : 110/65 mmHg, Fc : 85 bpm, T° 38,9°C, SatO2 : 98%, FR : 12/min, EVA : 0/10.

A votre examen clinique (que vous réaliserez) vous retrouvez des adénopathies dans toutes les aires ganglionnaires examinées et une splénomégalie, sans autres anomalies. Un bilan hépatique et des hémocultures sont déjà prévues.

Consignes :
Vous avez 8 minutes pour :

- Enoncer les aires ganglionnaires à palper
- Enoncer votre méthode de palpation de la rate
- Enoncer les examens complémentaires biologiques essentiels dans ce contexte

Vous ne devez pas :

- Réinterroger le patient sur ses antécédents et sur ses symptômes, vous pouvez directement lui proposer de l'examiner
- Faire un examen clinique complet

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station sans patient standardisé.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)	
Palpation des aires ganglionnaires	
Énonce la nécessité de palper l'aire ganglionnaire cervicale OU jugulo-carotidienne	1 pt
Énonce la nécessité de palper l'aire ganglionnaire sus-claviculaire	1 pt
Énonce la nécessité de palper l'aire ganglionnaire axillaire	1 pt
Énonce la nécessité de palper l'aire ganglionnaire inguinale	1 pt
Palpation de la rate	
Énonce palper la rate en hypochondre gauche	1 pt
Énonce la palpation de la rate du bas vers le haut ou en fléchissant les jambes du patient	1 pt
Manoeuvre facilitant la palpation de rate : - Dire au patient d'inspirer profondément et bloquer sa respiration - OU Fléchir la OU Positionner le patient en décubitus latéral droit	1 pt si un des 2 éléments
Prescription des examens biologiques	
Prescrit des sérologies virales OU prescrit une des sérologies suivantes : - sérologie EBV ou MNI test - sérologie CMV - sérologie Toxoplasmose	1 pt
Prescrit une NFS	1 pt
Prescrit un frottis sanguin	1 pt
Prescrit une sérologie VIH	1 pt
Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)	

10. APTITUDE À MENER L'EXAMEN CLINIQUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
N'explique pas au patient les gestes réalisés ou ne respecte pas le confort du patient	Explique peu les gestes réalisés	Explique les gestes réalisés et respecte le confort du patient	Donne l'information sur les gestes en expliquant les objectifs /les éléments recherchés et respecte le confort du patient	Agit sans erreur Met à l'aise

12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

TOTAL (max 20 items)	**15 points**

<u>Éléments de rétroaction :</u>

La rate est un organe profond, non palpable en situation physiologique et dont la palpation même en situation pathologique (sauf splénomégalie extrême) reste complexe. La palpation commence en hypochondre gauche et remonte progressivement sous les côtes.
Il faut connaître les outils pour faciliter sa palpation :

- demander au patient d'inspirer profondément et de retenir sa respiration pour pousser au maximum la rate vers l'abdomen,
- Eventuellement demander au patient de plier les cuisses
- Eventuellement positionner le patient en décubitus latéral droit, permettant de décoller la rate de la paroi thoracique en la faisant descendre en avant et vers la droite

Le contexte du patient oriente vers deux étiologies principales :

- une hémopathie en particulier (lymphome, leucémie lymphoïde ou myéloïde notamment) qui est l'objet principal des investigations

- une infection, subaigüe du fait de l'évolution depuis plusieurs semaines sans signe de gravité (pas de sepsis) et sans point d'entrée évident, orientant un peu plus vers une étiologie virale ou bactérienne torpide comme la tuberculose.

Les examens biologiques vont chercher des anomalies à la NFS et en particulier une lymphocytose ou toutes cytopénies pouvant témoigner d'un envahissement médullaire notamment.
Le frottis peut rapidement donner des éléments orientant vers un aspect atypique des cellules sanguines et potentiellement un syndrome mononucléosique.
La sérologie VIH est un réflexe diagnostic à réaliser tôt car il conditionne la prise en charge diagnostique (recherche d'infection opportuniste) et thérapeutique (anti-rétroviraux). De plus, les autres examens ne montreront pas nécessairement d'argument pour ou contre une primo-infection VIH (syndrome mononucléosique non systématique) qui en fait un réflexe diagnostique à part.

En moindre urgence (deuxième intention) dans le bilan étiologique, le bilan des infections pouvant mimer la présentation clinique d'une hémopathie, à savoir les infection EBV, CMV (une immunodépression sera alors à chercher) ou Toxoplasmose.
L'hémoculture est un réflexe à avoir en cas de fièvre sans argument pour une étiologie virale, ici l'examen reste utile mais la présentation clinique n'est pas très en faveur d'une bactériémie.

ECOS TACFA
SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Patient de 25 ans, inquiet car découverte par le médecin traitant de nombreux ganglions et d'une splénomégalie. Fatigué, sueurs depuis plusieurs semaines, perte de poids, asthénie "je ne vais pas bien".

Plan de la station ECOS :

Le patient peut d'emblée être installé sur une table d'examen pour être examiné. Il ne sera pas interrogé par l'étudiant.

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

« Bonjour Docteur, je suis adressé par mon médecin généraliste car il m'a découvert une grosse rate et des ganglions. Je tiens aussi à vous dire que j'ai perdu du poids depuis plusieurs semaines, que j'ai d'importantes sueurs la nuit jusqu'à en changer les draps. Je vous avoue que je suis assez inquiet, j'espère que vous allez trouver ce qui ne va pas. »

Identité du patient :

M. Baudelaire Adam, 25 ans, poids et taille non important (idéalement pas obèse pour faciliter la palpation de la rate). Perte de poids récente de 5 kg en 2 semaines

Mode de vie :

Étudiant en droit en 5ème année – Master 2, célibataire, pas d'animaux, pas d'enfants, ne voyage pas, sédentaire, aime lire et le cinéma.
Pas d'intoxication alcoolo-tabagique, pas d'allergie, pas de traitement.

Comportement global :

Inquiet mais ne verbalise pas beaucoup. Il va interrompre une fois pendant l'examen clinique l'étudiant pour demander si ça va, si c'est grave ou si il trouve ce qu'il a. Vêtement au choix.

Antécédents personnels :

Aucun

Antécédents familiaux :

Aucun

Médicaments :

Aucun récent ni ancien.

Symptômes positifs :

Le patient va peu/pas communiquer à part la phrase d'approche, l'étudiant n'aura pas à l'interroger.

Constantes :

TA : 110/65 mmHg, Fc : 85 bpm, T° 38,9°C, SatO2 : 98%, FR : 12/min
EVA : 0/10

Donnée complémentaire :

Aucune

Questions de relance :

Aucune
Par contre une fois installé et lors de l'examen clinique ou après, il pourra demander à l'étudiant une des remarques suivantes :

- « C'est grave docteur ? »
- « Qu'est-ce que vous regardez ? »
- « C'est normal ces ganglions ? »
- « Quels examens me conseillez-vous de faire ? »

L'étudiant ne sera pas directement évalué sur la réponse mais permettra de rendre la situation plus réaliste.

ECOS TACFA

FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

« Ambiance » consultation aux urgences :

- le patient peut d'emblée être installé sur la table d'examen (assis),
- ou alors étudiant assis à un bureau et le patient vient s'installer en face pour débuter la rencontre avant d'être redirigé vers la table d'examen par l'étudiant.

Matériel nécessaire à la station :

- Lit pour allonger le patient pour l'examen clinique
- IPAD pour examinateur
- Feuille de brouillon pour candidat
- Stylo pour candidat
- Feuille de brouillon pour évaluateur
- Stylo pour évaluateur

Documents présents dans la station :

- Feuilles d'évaluation de papier de secours